Application Infirmerie

Gestion des dossiers patients et des bilans de santé — résumé d'état

Champ	Valeur
Projet	**C:\Users\Alvarès\infirmerie-app**
Dépôt	github.com/Alvares-afk/infirmerie (public)
Pile	Django 6.1.1 · SQLite · Python 3.14 · Windows
Date du document	24/10/2026
État	**Application en service, à configurer avant usage réel**

1. Ce qui est en place

Module	État	Contenu
Fiches patients	■	Identité, allergies, médecin traitant, n° de dossier automatique
Consultations	■	Datées, motif, diagnostic, prescription, constantes, IMC calculé
Bilans de santé	■	Rattachés à la consultation, interprétation selon les normes
Fourchettes de référence	■	**Paramétrables par laboratoire**, signées et versionnées
Suivis	■	Échéances, détection de retard
Synthèse imprimable	■	Avec bandeau d'allergies
Point quotidien	■	Priorisé : immédiat / avant visite / à planifier
Relances	■	Brouillons — **aucun envoi automatique**
Journal d'accès	■	Lecture seule, **sans donnée clinique**
Deux rôles	■	Secrétariat / soignant, contrôle côté serveur

2. Sécurité — vérifié, pas supposé

• Contrôle des accès **côté serveur** : un compte secrétariat obtient 403 sur une URL de dossier clinique. Un lien direct ne donne rien.

• SECRET_KEY hors du fichier de configuration, lue depuis l'environnement. L'application **refuse de démarrer** en production sans elle.

• Mode debug piloté par variable d'environnement.

• L'administration Django n'est accessible qu'au compte admin : le soignant reçoit 403.

• Aucune donnée clinique dans le journal d'accès ni dans les URL — les logs du serveur ne contiennent que des identifiants numériques.

• Une panne du journal **ne bloque pas** l'accès au dossier : le soignant garde la main.

Règle d'or appliquée

« Normal » n'est prononcé que si le laboratoire a borné le côté qui compte. Trois cas donnent « à qualifier » : mention qualitative (« négatif », « traces »), ou aucune borne. Une borne haute seule suffit à conclure (enzymes), une borne basse seule non. Sans cette règle, un résultat dont on ignore la norme s'afficherait comme rassurant — le risque le plus grave possible ici.

3. Deux bases séparées

Les patients fictifs et les vrais dossiers ne partagent rien : une erreur sur la démonstration ne peut pas atteindre une donnée réelle.

Lanceur	Base	Contenu
demarrer_reel.bat	db_reelle.sqlite3	**Vrais dossiers patients** — vide, prête
demarrer_demo.bat	db.sqlite3	6 patients fictifs, pour essayer

Un **bandeau rouge permanent** en haut de chaque page indique la base ouverte.

Les sauvegardes sont séparées (sauvegarder_reel.bat / sauvegarder.bat).

Une restauration **refuse de franchir les deux bases** : restaurer une sauvegarde de démonstration sur les vrais dossiers est bloqué.

4. Vérifications

Contrôle	Résultat
Tests automatisés	**132 passent** (parcours, permissions, journal, briefing, relances, références, unités)
Rendu des écrans	12 écrans vérifiés pour les deux rôles
Isolation des bases	Vérifiée
Sauvegarde / restauration	Testées, y compris le refus de confusion

Neuf bugs réels ont été trouvés et corrigés, dont trois lors des derniers travaux : une valeur sans norme complète était classée **« normal »** (donc rassurante), une borne basse seule permettait de conclure à tort sur un résultat élevé, et des valeurs issues d'un compte rendu réel s'étaient retrouvées dans les tests versionnés.

5. À faire avant un usage réel

✓ Fait — les fourchettes de référence du laboratoire

Les normes ne sont plus des repères usuels : ce sont les bornes de votre laboratoire, chargées et vérifiées. **Le risque le plus sérieux de l'application est levé.** Il reste à compléter si votre laboratoire analyse d'autres paramètres sur une autre feuille (glycémie, créatinine, ferritine, lipides) : tant qu'ils ne sont pas dans la table, ils restent « à qualifier » — ce qui est le comportement voulu.

1. Changer les mots de passe des trois comptes — À FAIRE

Ils sont identiques pour l'instant. Un fichier secret.env.txt contenant un mot de passe en clair a été trouvé à la racine du projet ; il n'a pas été versionné, mais ce mot de passe est à considérer comme compromis.

2. Saisir un patient de bout en bout

Fiche, consultation, bilan, synthèse imprimée. Les vrais manques n'apparaissent qu'à l'usage — un champ inutile, une saisie qui fait trois allers-retours.

6. État du déploiement en ligne

L'application **tourne en local** : http://127.0.0.1:8000 — c'est là que la saisie de vrais dossiers se fait.

Point	État
Erreur de build Vercel	**Corrigée** — runtime Python inventé dans vercel.json, supprimé au profit d'un .python-version
Accès public	**Bloqué** — protection d'équipe Vercel, réglage d'organisation
Supabase	Base de démonstration connectée, jamais de données réelles
Compte Vercel	Projet rattaché à l'équipe **win-team5** — à confirmer

Pourquoi les données réelles restent en local

Supabase n'est **pas certifié HDS**. Héberger des dossiers patients chez eux poserait un problème légal français. L'hébergement local, avec accès par VPN et aucun port ouvert, reste la bonne voie pour un usage réel.

7. Points ouverts

Sujet	Nature
Durée de conservation des dossiers	Décision d'établissement
Sort du dossier au départ d'un patient	Décision d'établissement
Politique de purge du journal d'accès	Décision d'établissement
Module prophylaxie (spéc. LAB 04)	Modèle conçu — attend les calendriers et protocoles de l'établissement
Planification automatique (spéc. LAB 04)	Conçue — 4 tâches à automatiser sur 4 à proscrire

Sujet	Nature
Sources documentaires (protocoles, fiches types)	Conçue — attend l'inventaire des documents

Sur les six écarts entre la spécification LAB 04 et l'application, trois sont comblés : dossiers et bilans, point quotidien, relances.

Commandes utiles

Lancer les vrais dossiers : double-clic sur demarrer_reel.bat
Lancer la démonstration : demarrer_demo.bat
Sauvegarder les vrais dossiers : sauvegarder_reel.bat
Vérifier l'application : manage.py test dossier (132 tests)